

西药调配中不良的药物相互作用

鲍玉洁

(内蒙古乌兰察布市中心医院药剂科, 内蒙古 乌兰察布 012000)

【摘要】随着我国慢性病病人的增多, 联合用药已成为公众关注的热点和焦点, 因此在调配工作中需要格外注意药物不良相互作用问题, 才能做到合理用药, 预防药源性疾病等一系列问题的发生。

【关键词】联合用药; 不良相互作用; 合理用药; 药源性疾病

【中图分类号】R453.9

【文献标识码】B

【文献编号】ISSN. 2095-8242. 2017. 01. 0743. 01

1 在药理学上的相互作用

1.1 影响吸收

(1) 四环素类、喹诺酮类及异烟肼、左旋多巴与含钙铁、镁、铝等金属离子的药物能发生螯合反应, 降低溶解度, 难以被胃肠道吸收, 使药物的疗效降低^[1]; 法莫替丁片与含多量黄酮类的药物如银杏叶片, 复方丹参片同服产生络合反应, 影响疗效^[2]。

1.2 影响分布

银杏叶片与地高辛合用可促进主动脉内皮细胞内钙离子水平, 使地高辛的游离血药浓度明显升高, 造成中毒^[3]。

1.3 影响代谢

酶抑制反应, 大环内酯类的红霉素、罗红霉素、克拉霉素和唑类抗真菌药依曲康唑、酮康唑、同属 CYP3A4 酶抑制剂, 不能与由此酶代谢的抗组胺药如氯雷他定、阿司咪唑、西替利嗪和抗高血压药如氨氯地平、硝苯地平、非洛地平及降脂药辛伐他汀、洛伐他汀、氟伐他汀同用, 因酶抑制作用使这三类药物的血药浓度升高, 使过敏患者发生尖端扭转型严重心律失常; 使高血压患者血压过度降低和心动过速; 使高血脂患者导致骨骼肌溶解等严重不良反应; 同理, 磺胺药、西米替丁、氟伐他汀、氟康唑、奥美拉唑、泮托拉唑、地西泮同属 CYP2C9 酶抑制剂, 与由此酶代谢的药物如格列本脲、格列美脲及抗凝药华法林同用, 使降糖药作用增强, 引起低血糖休克; 使抗凝患者发生出血^[4-5]。

1.4 影响排泄

含有机酸成分的川穹嗪注射液与磺胺药、大环内酯类、利福平、阿司匹林等酸性药物合用时, 因尿液被酸化, 使乙酰化后的磺胺不易溶解, 在肾小管中析出结晶, 引起结晶尿、血尿乃至尿闭、肾功能衰竭; 增加大环内酯类的肝毒性, 甚至引起听觉障碍; 可使利福平和阿司匹林的排泄减少, 加重肾脏的不良反应^[6]。

2 在药理学上的相互作用

2.1 药理作用相加产生不良反应

(1) 钙制剂不能与地高辛同用, 因为钙离子为应激性离子, 与地高辛有协同增强心肌收缩力的作用, 从而增强地高辛的作用和毒性。

(2) 利尿药螺内酯、氨苯蝶啶、阿米洛利不能长期与降压药苯那普利、卡托普利、依那普利联用, 因为前者为保

钾利尿药, 后者的不良反应致血钾升高, 联用后致高血钾症, 甚至严重心脏阻滞乃至心搏停止。

2.2 药理学上的拮抗作用

复方甘草片、复方甘草酸苷胶囊具有糖皮质激素样作用, 还能促进糖原异生, 使血糖升高, 减弱降糖药胰岛素、格列本脲等的药效; 碘喉片、西地碘片、不宜与治疗甲亢的药物如甲硫咪唑, 丙基硫氧嘧啶等同用, 因其所含的碘能促进酪氨酸的碘化, 使体内甲状腺素合成增加, 不利治疗。

3 产生或增加不良反应

(1) 含麻黄碱的感冒药如白加黑、新康泰克不宜与单胺氧化酶抑制剂如痢特灵、司来吉米、异烟肼联用, 因此酶被抑制后, 使该酶类神经递质去甲肾上腺素不能被破坏, 麻黄碱又能促进去甲肾上腺素大量释放, 导致呼吸困难, 心律不齐, 心肌梗死等严重不良反应, (2) 临床上三唑仑与阿米替林、氟西汀与氯氮平、喷司他丁与环磷酰胺联用的致死性药物相互作用时有报告^[7]。

综上所述, 不良的药物相互作用表现在药理学及药效学的各个方面, 其中代谢性相互作用发生率最高, 这就要求我们在药学实践中, 掌握药物的理化性质, 化学结构, 作用机制及药物间的相互作用等药学专业知识, 把那些影响疗效的, 严重的甚至致死的药物相互作用减少到最低程度, 以保证临床用药的安全、有效、合理。

参考文献

- [1] 中国执业药师协会. 全国执业药师继续教育教材 [M]. 北京: 中国医药出版社, 2007: 216-217.
- [2] 中国执业药师. 中药学综合知识与技能 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 234-235.
- [3] 巫朝伦, 韦建军, 刘东方. 银杏叶对兔体内地高辛药动学的影响 [J]. 中国药学报, 2000, 28(4): 3.
- [4] 骆文香, 张银娣. 药物代谢中的肝细胞色素 p450 药理学进展 1999; 23: 27-33.
- [5] 刘保国, 李志英, 李宗珊, 等. 抗组胺药临床应用 [J]. 临床合理用药杂志, 2015, 8(8): 85-86.
- [6] Yuan R, parmelee T, Balian JD, et al. In vitro metabolic interaction studies: Experience of the food and drug administration. Clin. Pharmacol. Ther, 1999(66): 9-15.

本文编辑: 贺攀